

MEDQUERY AI - DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE CLÍNICO

ID Documento: MQ-PSY-404

Título: Protocolo de Agitación Psicomotriz Extrema en la Emergencia

Diagnóstico Presuntivo: Agitación Psicomotriz / Crisis Psiquiátrica Aguda

Síntomas Guía: Agresividad física, verbosidad, heteroagresividad, amenazas

Especialidad: SPEC_{EMERG}

Versión: v1.0 (Octubre 2026)

Población Objetivo: Adulto

Medical Owner: Jefatura de Salud

BLOQUE DE ACCIÓN OPERATIVA - TRIAGE: URG_L2_ORANGE

Acción de Primera Línea: Garantizar la seguridad del entorno físico inmediatamente. Intentar desescalada verbal breve; si no hay respuesta o existe riesgo inminente de violencia, proceder de forma coordinada a la contención mecánica (física) e iniciar sedación farmacológica de urgencia.

Drogas de Elección:

- *Protocolo Combinado Estándar (Vía IM):* Haloperidol 5 mg IM asociado a Midazolam 5 mg IM en la misma jeringa. Repetir a los 20-30 minutos si la agitación extrema persiste (Dosis máxima de Haloperidol: 15 mg/día).
- *Alternativa en Paciente Colaborativo:* Olanzapina 5 a 10 mg VO o Lorazepam 2 mg SL.

Alerta de Seguridad / Contraindicación Crítica: Prohibido intentar una contención física con menos de 4 operadores entrenados. Nunca aplicar Midazolam ni benzodiacepinas si se sospecha intoxicación aguda por alcohol o depresores del sistema nervioso central debido al riesgo crítico de paro respiratorio. Está estrictamente prohibido colocar al paciente en decúbito prono durante la sujeción mecánica por riesgo de asfixia posicional.

1 Introducción y Aspectos Legales

El manejo del paciente con agitación psicomotriz extrema requiere una intervención rápida y protocolizada para salvaguardar la integridad del paciente y del personal de salud. Toda medida de contención física o farmacológica involuntaria debe implementarse bajo los principios de necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad, quedando registrada detalladamente en la historia clínica como resguardo legal institucional.

2 Fases Operativas de la Intervención

El abordaje debe seguir una secuencia estricta basada en el nivel de agresividad:

1. **Desescalada Verbal:** Mantener una distancia de seguridad (mínimo 2 metros), tono de voz calmado, evitar el contacto visual fijo y ofrecer opciones terapéuticas. Esta fase se obvia ante agresiones físicas en curso.
2. **Contención Mecánica Coordinada:** Requiere un líder que dirija y un operador asignado para cada extremidad (mínimo 4 personas, idealmente 5 para asegurar la sujeción de la cabeza). Se debe colocar al paciente en decúbito supino en una camilla articulada y fijar las sujeciones homologadas a la estructura de la cama, nunca a las barandas móviles.
3. **Contención Farmacológica:** Administración inmediata de los psicofármacos indicados en el bloque de emergencia para asegurar la sedación consciente del paciente.

3 Monitoreo Clínico y Seguridad

Una vez que el paciente se encuentra contenido mecánicamente, el personal de enfermería debe realizar controles estrictos cada 15 minutos:

- Evaluar el estado de la vía aérea, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno (O_2).

- Verificar la perfusión tisular y pulsos periféricos en las extremidades sujetadas para descartar compromiso vascular o lesiones por tracción.
- Controlar la posición de la cabeza para prevenir la broncoaspiración en caso de emesis.

4 Criterios de Retirada de la Medida

La sujeción mecánica debe suspenderse lo antes posible, de forma gradual (retirando primero los miembros superiores de a uno por vez) una vez que el paciente se encuentre tranquilo, orientado o bajo el efecto de sedación segura, mostrando ausencia total de conductas hostiles hacia el entorno durante un período mínimo de 30 minutos.